EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84722
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 17-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: JOSE ROSENDO FUENTES BURGOS			RUN	: 4.712.749-1
F.Nac	: 18-11-1943	Edad	: 80 AÑOS, 5 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	:		
Fecha Ingreso	: 2024-04-30	Fecha Egreso	: 17-05-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONIA BILATERAL TRATADA
INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA + DERRAME PLEURAL BILATERAL
¿ENCEFALOPATIA DE WERNICKE?
ACV isquémico MULTIPLES / Epilepsia vascular / DEPENDENCIA MOD-SEVERA
Ca de próstata
IC - VALVULA MECANICA AORTICA Y MITRAL EN TACO CON WARFARINA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

CONSULTA POR DISNEA Y DESATURACION, RECIBE TTO AMBULATORIO CON AZITROMICINA SIN RESPUESTA. EN SUS EXS DESTACA ELEVACION PARAMETROS INFLAMATORIOS E INR 10
Ingresa a urgencias desaturando, polipneico con UMA, AngioTAC de tórax: negativo para TEP, extensas áreas de vidrio esmerilado
RECIBE TERAPIA AB EMPIRICA CON CEFALOSPORINA DE 3 GENERACION CON EXCELENTE RESPUESTA EN LO RELATIVO A PARAMTEROS INFLAMATORIO/INFECCIOSOS, SIN EMBARGO CON LENTA RECUPERACION DE SU INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. EN TAC TORAX DE CONTROL SE OBSERVA INCREMENTO DERRAME PLURAL POR LO QUE SE INTENSIFICAN MEDIDAS DE MANEJO INSUFICIENCIA CARDIACA Y SOPORTE VENTILATIRO CPAP/VMNI. ADICIONALMETNTE PRESENTA COMPROMISO CONCIENCIA TRANSITORIO, VALORADO POR NEUROLOGIA CON NEUROIMAGEN DESCARTANDOSE NUEVO EVENTO CEREBROVASCULAR.
CON TODO, SE OBSERVA POSITIVA EVOLUCION CLINICA GENERAL QUE PERMITE CONTINUAR SU MANEJO EN CONTEXTO DE HOSPITALIZACION DOMICILIARIA.

PLAN DE MANEJO:

CONTINUAR MANEJO EN HOSPITALIZACION DOMICILIARIA
KNT MOTOR/RESPIRATORIO
FONOAUDIOLOGIA/DEGLUCION
MINIMO O2 SUPLEMENTARIO PARA SAT > 88-90%
PACIENTE EN MANEJO PROPORCIONAL -> TECHO VMNI

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO SEMISENTADO
2. NUTRICION POR SNG -> OSMOLITE 50 CC/h + AGUA 150 CC C 6HRS
3. LIMPIEZA DE CAVIDAD ORAL
4. KNT - FONO
5. ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 25 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. LEVETIRACETAM COMPRIMIDO 500 MILÍGRAMOS 2 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
8. TAMSULOSINA COMPRIMIDO 0,4 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. WARFARINA COMPRIMIDO 5 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
10. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
11. LACTULOSA SOLUCIÓN 65% FRASCO 200 MINILITROS 5 CC AL DIA VO
12. EMPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
13. SALBUTAMOL INHALADOR 100 MICROGRAMOS / DOSIS 2 PUFF C/6 HRS
14. IPRATROPIO INHALADOR FRASCO UNIDAD 4 PUFF C/6 HRS
15. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 2 PUFF C/12 HRS

EXÁMENES Y RESULTADOS

EXS 16.5.24 -> INR 2.6, HB 10, CREA 1.5, BUN 71, NA 146, K 3.7, PH 7.55, PO2 70, PCO2 31

OBSERVACIONES:

RETOMAR CONTROLES POLITACO

CALDERON SOLIS CRISTIAN JOSE
MEDICO TRATANTE
15161784-0

JEFE SERVICIO